EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 94986
SERVICIO : UTI HSC
FECHA : 2024-10-16 12:37:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: JOSE HUMBERTO MU OZ GONZALEZ			RUN	: 8.563.989-7
F.Nac	: 04-09-1958	Edad	: 66 AÑOS, 1 MES	Género	: Masculino
Dirección	: TRES ESQUINAS			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 68029228		
Fecha Ingreso	: 2024-10-02	Fecha Egreso	: 2024-10-16 12:37:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I26.9-EMBOLIA PULMONAR SIN MENCIÓN DE CORAZÓN PULMONAR AGUDO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. TEP LII, PESI score 115 (Riesgo ALTO)
2. Insuficiencia cardíaca congestiva FEVI 33%, descompensada
3. Obs. Sdme. cardio-renal - LRA KDIGO 2/ ERC etapa 3b
4. Transaminitis aguda en estudio - Obs Hepatitis isquémica
5. Antecedentes crónicos: HTA, ICC, cardiopatía coronaria, Pendiente DAI-R De cuidado

Procedimientos LA 07/10 5 dias, CUP 07/10 4 dias.

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I26-EMBOLIA PULMONAR. (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. I50-INSUFICIENCIA CARDIACA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. N18.3-ENFERMEDAD RENAL CRONICA,ESTADIO 3 (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
4. I10-HIPERTENSION ESENCIAL(PRIMARIA) (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
5. Z95.5-PRESENCIA DE ANGIOPLASTIA, INJERTOS Y PROTESIS CORONARIAS (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente masculino, 66 años, con antecedentes de IAM (4), HTA, IC con FEVI 33%, BRI, ERC IIIB. en espera de instalación de resincronizador. En ultimo control se disminuye entresto a 50 cada 12 ingresa el dia 02/10 por tos, cansancio y malestar general
persistente post tratamiento de neumonía hace 1 mes. Al ingreso hipotenso, saturando 97% ambiental, sin apremio respiratorio. Se solicitan exámenes de laboratorio en los que destaca Creatinina: 2,00 mg/dL, PCR 20,6 mg/L, Potasio 6,00 mmol/L, NT-proBNP >25.000 pg/mL, Dímero D 4.500,4 ng/mL. Se inician medidas hipokalemiantes con buena respuesta y se solicita AngioTC de torax que informa hallazgos compatibles con TEP en LII, por lo que se decide su ingreso para continuar manejo. Inicialmente hospitalizado en medicina, sin embargo durante el fin de semana se intenta iniciar anticoagulación con warfarina pero eleva INR >11. Al control de examenes de laboratorio con alza de transaminasas y deterioro de función renal asociado a hipotensión.
Dado lo anterior se realiza IC UTI y se decide su ingreso para manejo. Con evolucion favorable en la unidad, actualmente sin requerimiento de soporte con DVA, sin soporte ventilatorio, normosaturando a FIO2 ambiental, se reinicia TACO con acenocumarol, al inicio con INR hasta 6, hoy INR en 3.37, se reiniciara acenocumarol 1/4 comprimido con ajustes segun INR, sin dolor abdominal, transaminitis en descenso franco, con mejoria de nauseas post uso de BZD. Con buena tolerancia a movilización por kine se decide hoy traslado a HODOM.
hoy paciente estable. Hemodinamia autosostenida, con PA en rango bajo, normocardico. Bien perfundido a distal. BIC de heparina suspendida hace 72h. Se mantiene con INR sobre rango terapéutico pero a la baja: 6.5-->5.7 -->3.34, Ventilando espontaneo a FIO2 ambiental con buena mecánica ventilatoria. Afebril, PI bajos , sin conflictos infeccioso. AKI en curso, con mayor deterioro de creatinina: 2.9-->3.5-> 3.7 con hiponatremia e hiperkalemia sostenida a pesar de ajuste de furosemida, se mantiene con furo ev cada 12 hrs. Na 130. K 5.6.Metabólicamente estable, glicemias dentro de rangos normales. Se mantiene sin encefalopatía.

PLAN DE MANEJO:

Planes :
1. Hemodinamia/cardio: hipotensión permisiva en contexto de IC FEVIr (PAM 60).Reinicio progresivo de betabloqueo. mantener restricción hídrica.
2. Hematológico: Se inicio traslape con acenocumarol (falla renal) ya que función hepática se encuentra en recuperación. Mantiene INR sobre rango. Reiniciar mañana INR hoy 3.34

3. Ventilatorio: Rehabilitación kinésica respiratoria por kine
4. Infeccioso: Sin conflicto infeccioso.
5. Digestivo: Alza transaminasas con hiperbilirrubinemia pudiera ser 2° ICC isquemia (hipotensión severa). Se suspenden fármacos potencialmente hepatotóxicos. Se realizó Eco abdominal sin hallazgos de relevancia.
6. Renal: antecedente ERC etapa 3 (VFG 38 / crea 2.0 aprox basal), cursando falla renal aguda con leve hiponatremia, sin criterios TSR de urgencia. Corrección ELP e inicio alopurinol.
7. Metabólico: Con regular tolerancia a regimen oral por nauseas persistentes. con buen manejo de nauseas con benzodiacepinas

INDICACIONES AL ALTA

1. Indicaciones Reposo relativo asistido
2. Régimen hiposódico / Restricción hídrica 800 cc/dia
3. Omeprazol 20 mg antes desayuno vo
4. Acenocumarol reiniciar mañana 1/4 de comprimido dia
5. Bisoprolol 2.5 mg al día vo AAS 100 mg/dia vo
6. Furosemida 40mg vo cada dia
7. Alopurinol 100 mg al dia vo
8. Bromuro de ipratropio 4 puff c/6 hrs
9. Salbutamol 2 puff c/6 hrs
10. PEG 17 grs 1 sobre c/12 hrs vo
11. Clonazepam 0,5 mg c/24 hrs vo
12. Bicarbonato 2 g cada 8h vo
13. Por ahora no atorvastatina, entresto o dapaglifozina

EXÁMENES Y RESULTADOS

16/10/24: Crea 3.7, Fa 152, TGO 50, TGP 287, GGT 201, PCR 41, Urea 219, Nu 102, INR 3.34 TTPA 41, Leuco 8.700, Hcto 47.1, Hb 15.1, Plaquetas 71, GSV Ph 7.43, PCO2 28, PO2 37, HCO3 19.1 15/10/24: Crea 3.7, bun?, ELP 128/5.4/99, HB 15.1, plaq 65000, leucos 8600, pH 7.4, HCO3 15,4, pO2 106, pCO2 24.8, INR 5.7, TTPA 45 14/10/24: Crea 3.4 (VFG 18.21) ELP 128/5.5/96 12/10/24 Crea 2.40, Fa 137, Bili T 3, Bili I 1.93, Bili D 1.07, GOT 94 , GPT 486, GGT 300, Urea 160, ELP 133/4.7/100, Hb 15.2, GB 11200, plaquetas 66.000, INR 1.43, TTPK 53, Ph 7.44, HCO3 19, PCO2 27.5, PO2 105 11/10/24: Crea 2.60, Fa 155, Bili T 2.70, Bili I 1.45, Bili D 1.25, TGO 145, TGP 664, GGT 346, Urea 159, ELP 135/4.3/101, Hb 15.5, INR 1.35, TTPK 53, Ph 7.40, HCO3 11.5, PCO2 18, PO2 118 09/10/24: Glicemia : 104, Albumina : 3,7, Creatinina : 3,30, Fosfatasa Alcalina : 180, Bilirrubina Indirecta : 1,17, Bilirrubina Directa : 1,53, Bilirrubina Total : 2,70, ASAT/GOT : 688, ALAT/GPT : 1.353, Gama GT : 397, Clearence Calculado(MDRD) : 18,85 ml/min/1,73, Proteina C Reactiva : 67,5, Nitrógeno Ureico : 79, Uremia : 168, Sodio (Na) : 136, Potasio (K) : 4,10, Cloro (Cl) : 104, Recuento de leucocitos : 8,600, Recuento Hematies : 5,84, Hematocrito : 48,1, Hemoglobina : 15,5 Plaquetas : 74, INR : 1,91, Tiempo de Protrombina % : 42, Tiempo de Protrombina seg : 24,3, TTPA (seg) : 91 *Procalcitonina : 0,93, pH : 7,43, pCO2 : 29,0, pO2 : 67,3, HCO3 ACT. : 19,3. 08/10: glic 97 Alb 3.7 crea 2.8 PCR 69 ProBNP 30502 TTPA 136 INR 1,86 GSA pH 7.42 pCO2 26,6 pO2 103 Bic 17.5 sat 99% FiO2 21% BT 3.1 BD 1.6 BI 1.5 GOT/GPT 1060 (1268)/1590 (1740) GGT 438 FA 200 TP 44% virus hepatotropos (-) 07/10: Glicemia 93 Crea 3 Clearance 21 FA 206 Bili total 3.1 Bili directa 1.57 GOT 1268 GOT >1740 GGT 438 CK 261 CKMB 21 Col total 136 HDL 28 LDL 91 VLDL 17 Lactato 1.9 Tg 87 PCR 61.5 Uremia 144 Na 131 K 4.7 Cl 102 GB 9400 Plaq 71.000 Hb 15.2 VHS 2 INR 2.75 DD 22733 pH 7.41 PCO2 27 PO2 47 HCO3 17.4 08/24: Crea 1.8 VFG 38 (desde 11/23 deterioro lento progresivo)

OBSERVACIONES:

Paciente en condiciones de traslasdo a HODOM.

Alexandra Molina
MEDICO TRATANTE
26074882-3

JEFE SERVICIO